

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

habit please tell your doctor.

5. During the procedure

For All Devices

A fine needle (IV cannula) will be inserted into a vein in your arm.

Ultrasound will be used to look at the veins and a suitable vein for the catheter will be selected.

Local anaesthetic and sedation will be injected.

A small cut is made in the skin over the vein.

Using ultrasound as a guide the needle will be inserted into your vein. You may be asked to hold your breath for several seconds while the catheter is inserted. The tip of the catheter will be positioned using x-ray guidance in a major blood vessel next to the heart. The catheter does not go into your heart.

When the catheter is in the correct place a chest x-ray will be taken to confirm its placement.

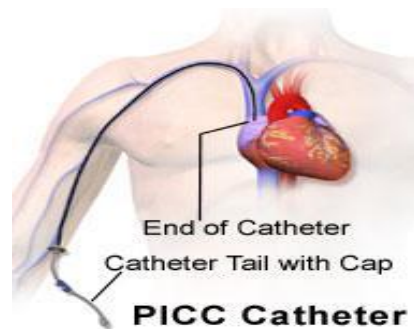
Non-Tunneled Catheter

The catheter is inserted directly into the vein and is held in place with sutures and a dressing. This kind of catheter might stay for a week.

Tunneled Catheter

A small cut is made in the skin on your chest and the catheter is pushed (tunneled) under your skin until it reaches the vein to be entered.

Tunneled Catheters are held in place with sutures. One or two sutures are also required to close the small cut over the vein at the base of the neck. Dressings will be applied. This kind of catheter might stay for a month.



The recovery time varies depending on the device inserted and the sedation given. It can be anywhere between 2 to 4 hours.

The IV cannula will be removed after you have recovered.

Following the insertion of your device it is normal to experience some tenderness and bruising for about 24 to 48

5. أثناء الإجراء

لجميع الأجهزة:

يتم إدخال إبرة رفيعة في أحد الأوردة في ذراعك (خط وريدي).

تستخدم الموجات فوق الصوتية لرؤية الأوردة الموجودة أسفل العنق (يستخدم أحياناً وريد في أعلى الفخذ) ليتم اختيار وريد مناسب لتحمل القسطرة.

يحقن المخدر الموضعي والدواء المسكن . يتم عمل شق جراحي صغير في الجلد فوق الوريد.

باستخدام الموجات فوق الصوتية للتوجيه ، يتم إدخال الإبرة في الوريد . قد يطلب منك أن تحبس أنفاسك لثوان معدودة بينما يتم إدخال القسطرة. يتم وضع طرف القسطرة في وعاء دموي رئيسي قريب من القلب وذلك بتوجيه من الأشعة السينية. لا يتم إدخال القسطرة إلى القلب.

عندما تكون القسطرة في مكانها الصحيح يتم أخذ أشعة للصدر للتأكد من موقعها.

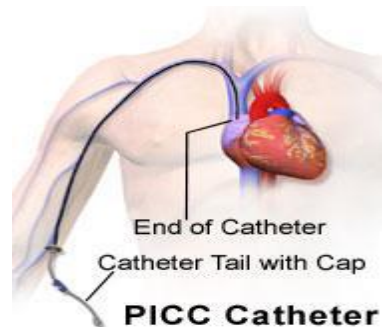
القسطرة غير النفقية

يتم إدخال القسطرة مباشرة إلى الوريد ويتم تثبيتها في موقعها بغرز جراحية وضما. يمكن لهذا النوع من القسطرة البقاء لمدة أسبوع.

القسطرة النفقية

يتم عمل شق جراحي صغير في الجلد على صدر المريض ويتم دفع القسطرة تحت الجلد (عمل ما يشبه النفق) حتى تصل إلى الوريد الذي تم اختياره.

يتم تثبيت القسطرة النفقية في موقعها بالغرز الجراحية . تكون هناك حاجة أيضاً لغرزة أو غرزين لإغلاق الشق الجراحي فوق الوريد أسفل العنق. يتم وضع الضما. يمكن لهذا النوع من القسطرة البقاء لمدة شهر.



فترة النقاهة بعد الإجراء تتوقف على الجهاز الذي تم إدخاله والدواء المسكن الذي تم إعطائه . قد تتراوح بين 2-4 ساعات.

تتم إزالة الخط الوريدي بعد انتهاء فترة النقاهة.

من الطبيعي أن تشعر بالألم عند لمس منطقة الإجراء أو أن تكون هناك كدمة لفترة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

hours. Panadol and ice packs may help this.

You will be educated about your Central Vascular Access Device, how to take care of it and the recommended level of activity advised while it is in place.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure and with having a device inserted can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the insertion site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is usually stopped by applying further pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The device may become kinked and need repositioning or removal.
- The device may become blocked and need medications to unblock or may need to be removed.
- (Tunnelled and Non-tunnelled catheters only) The device may be accidentally removed if pulled or tugged on.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection at the skin, requiring antibiotics and/or further treatment.
- Infection in the device, requiring the device to be removed.
- Pneumothorax, a collection of air around the lining of the lungs. This usually resolves by itself but sometimes may require a tube to be inserted into the chest.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Failure to gain access to the vein. This may require a second attempt from a different location.
- Blood clot blocking the vein may require medication to treat.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.

Rare risks and complications include:

- Injected medications may leak outside of the vein under the skin and into tissue, this may require treatment.

تتراوح ما بين 24-48 ساعة بعد إدخال الجهاز . قد يساعدك تناول البنادول أو وضع كمادات من الثلج في التغلب على ذلك.

سيتم إرشادك وتعليمك ما يتعلق بجهاز الدخول المركزي للأوعية الدموية وكيفية العناية به , و يتم تقديم النصح لك حول مستوى الأنشطة التي يمكن أدائها أثناء وجود الجهاز في موضعه.

6. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء وبوجود جهاز داخل الجسم تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.
- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة الإجراء. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث التواء للجهاز وقد تكون هناك حاجة لإعادته إلى موضعه أو لإزالته.
- قد يحدث انسداد للجهاز ويتطلب أدوية لفتح الانسداد ، وقد يتطلب الأمر إزالته.
- فقط لل (القسطرة غير النفقية و القسطرة النفقية) قد يخرج الجهاز من موقعه عن طريق الخطأ إذا حدث له سحب أو جر .
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً و من المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى في الجلد يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- عدوى في الجهاز تتطلب إزالة الجهاز.
- وجود تجمع للهواء حول بطانة الرئة وهو ما يسمى بـ (استرواح الصدر). عادةً ما يتوقف ذلك من تلقاء نفسه ، إلا أنه أحياناً تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب في الصدر.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- فشل في الوصول إلى الوريد . قد يتطلب ذلك المحاولة مرة أخرى في موضع آخر.
- انسداد الوريد بخثرة دموية مما قد يتطلب علاجها بأدوية.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- قد تتسرب الأدوية التي يتم حقنها من خارج الوريد إلى تحت الجلد وإلى داخل الأنسجة. قد يتطلب ذلك علاج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- A fast or irregular heart beat. This usually resolves on its own or may need further treatment.
- The catheter tip may move from the original placement. The device may need to be removed.
- An air bubble enters the blood stream. This can travel to the heart causing a heart attack or to the brain causing a stroke.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia, emergency treatment may be necessary
- Stroke resulting in brain damage.

8. What are the safety issues when you leave the hospital?

If you were sedated, this will affect your judgment for about 24 hours. For your own safety:

- Do NOT drive any type of car, bike or other vehicle.
- Do NOT operate machinery including cooking implements.
- Do NOT make important decisions or sign a legal document.
- Do NOT drink alcohol, take other mind-altering substances, or smoke. They may react with the anaesthetic drugs.
- Have an adult with you on the first night after your procedure.

Take care not to pull on the device. Notify your doctor immediately if your device has been tugged or has fallen out.

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

- pain, unrelieved by simple pain killers
- continuous bleeding or swelling at the skin around the catheter
- redness or inflammation on the skin around the catheter
- a fever
- swelling in the arm on the side the device is inserted in
- other warning signs you may have been asked to be aware of.

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة. غالباً ما يتعافى ذلك تلقائياً أو قد يتطلب علاج.
- قد يتحرك طرف القسطرة من موقعه الأصلي الذي وضع فيه. قد يتطلب ذلك إزالة الجهاز.
- قد تدخل فقاعة هواء إلى مجرى الدم وقد تصل إلى القلب مسببة أزمة قلبية ، أو قد تصل للدماغ مسببة سكتة دماغية.
- زيادة خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيء.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى. مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

إذا كنت قد تلقيت دواءً مسكناً ، فإنه قد يؤثر لحوالي 24 ساعة على قدرتك في اتخاذ القرار. لضمان سلامتك :

- لا تقد أي نوع من المركبات كالسيارة أو الدراجة أو غيرها. يجب أن يرافقك إلى المنزل شخص عاقل بالغ ومسؤول عند خروجك من المستشفى.
- لا تقم بتشغيل أي آلات بما في ذلك أدوات الطهي.
- لا تتخذ أي قرار مهم ولا تقم بتوقيع أي مستند قانوني.
- لا تحتسي الكحول أو تتناول أي من المواد المسببة للهلوسة ، ولا تدخن . كل ذلك قد يتفاعل مع الدواء المسكن.
- استعن بشخص بالغ يظل بجوارك في الليلة الأولى بعد الإجراء.

كن حذراً من تعرض الجهاز لأي سحب . أبلغ الممرض أو طبيبك إذا تعرض الجهاز للسحب أو خرج من موضعه.

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو عانيت أي مما يلي:

- ألم لا يتعافى باستخدام مضادات الألم المعتادة.
- نزيف مستمر أو تورم مستمر في منطقة إدخال القسطرة
- احمرار أو التهاب في موضع إدخال القسطرة.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- تورم في الذراع في الجهة التي وضع فيها الجهاز.
- ظهور أي علامات أخرى كان الطبيب قد نبهك إليها.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

أمور أتناقش حولها مع طبيبي
